

		X ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
		NS 22232882357 / 420	
KIMIYOSHI KUROSAWA			
IDADE: 69a	PESO: 85	ALTURA: 163	PROFISSÃO: <i>Quintando</i>
SINTOMAS: <i>Boca seca - Asia - esquecido.</i>			
QUEIXAS: <i>Sonolência (TV) -</i>			
MEDICAMENTOS: <i>Xarelto / Sotalol / Vit D / Magnésio / Rosuvast.</i>			
<i>HAS - Iolesterol / Arritmia.</i>			
MÉDICO: <i>Dr. Bruno / Dr. Eike</i>			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>Pilates (2x semana)</i>			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (19h)			
HORA QUE DORME: 21hs		HORA QUE ACORDA: 3:30	
COCHILHO (X) SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: <i>nasal</i>		BANHEIRO: 1X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: <i>Bombase</i>		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>nao</i>	MALLAMPATI:	IAH: <i>68.5</i>	SPO2: <i>82%</i>
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <i>Bombase / 1 Stent cardíaco</i>			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:		IMC: <i>32.</i>	
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS <i>Der no joelho</i>			
<i>20/08/23 - Avaliação da PSG.</i>			
<i>27/08/24 Consulta Online</i>			
<i>P = 6 - 12 cmH₂O</i>			
<i>IAH = 3,6 e/ev</i>		<i>Bem adaptado</i>	
<i>m. de uso: 6h 2'</i>		<i>Oriento higiene da</i>	
<i>fuga: 1,2 l/m</i>		<i>masca</i>	
<i>Natália</i>			
<i>03/09</i>	<i>P = 8,0 cmH₂O</i>	<i>Bem adaptadas,</i>	
<i>24</i>	<i>IAH = 2,9 e/ev</i>	<i>Oriento sobre a higiene</i>	
	<i>m. de uso: 6h 50'</i>	<i>fua.</i>	
	<i>Fuga = 3 lpm.</i>		
<i>19/09</i>	<i>P = 8,0 cmH₂O</i>	<i>Bem adapt., não se</i>	
<i>24</i>	<i>IAH = 0,4 e/ev</i>	<i> sente desconforto.</i>	
	<i>m. de uso = 19 lpm.</i>	<i>fua</i>	
<i>31/10</i>	<i>P = 7,8 cmH₂O</i>	<i>Relata que está 4º</i>	
<i>24</i>	<i>IAH = 3,5 e/ev</i>	<i>nº de horas de sono</i>	
	<i>m. de uso: 5h 40'</i>	<i>fua claudia</i>	
	<i>fuga = 1,4 lpm.</i>		
<i>10/12</i>	<i>P = 7,8 cmH₂O</i>		
<i>24</i>	<i>IAH = 2,5 e/ev</i>		
	<i>m. de uso = 5h 13'</i>		
	<i>fuga = 2,6 lpm.</i>	<i>Juan Claudio</i>	

RitmoCheck

São José dos Campos, 16 de maio de 2024

Dra. Érika Olivier Vilela Bragança - CRM 83.944
Doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo

A/C Otorinolaringologista

Prezado colega,

Encaminho o Sr. Kimiyoshi Kurosawa, portador de fibrilação atrial evoluindo com bradicardia sinusal e roncos. Realizou Polissonografia que evidenciou Apnéia Obstrutiva do Sono severa com dessaturações de oxiheoglobina. Solicito sua avaliação quando a presença ou não de obstrução mecânica e tratamento indicado (correção da obstrução ou uso de CPAP?).

Coloco-me a disposição para qualquer eventualidade.

Atenciosamente,

Dra. Érika Olivier Vilela Bragança
CRM 83.944, RQE 44971 e 449711

Dra. Érika Olivier Vilela Bragança
Cardiologia/Eletrofisiologia
Estimulação Cardíaca Artificial
Doutora em Ciências pela UNIFESP
CRM 83.944, RQE 44971 e 449711

www.ritmocheck.com.br

Av. Cassiano Ricardo, 319 sala 504 - Pátio das Americas, Jd Aquarius - CEP 12446-870
(11) 3911-9903, (12) 99139-9241 - São José dos Campos/SP - contato@ritmocheck.com.br

Nome: KIMIYOSHI KUROSAWA
Data de Nascimento: 9-11-1954
IMC: 31,62
Sexo: Masculino
Data do exame: 11-07-2024

Peso: 84 kg
Altura: 1,63 m
Médico: DR. ERCIO ALVARO NAKANO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 11-07-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 531,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 13,5 e 85,5 minutos. O tempo total de sono foi de 292,5 min, eficiência de 55,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 57,6%; estágio N3: 15,9%; sono REM: 24,3%. O índice de despertares foi de 5,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 13,9/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 68 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 85%, permanecendo 4,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 41 - 60 bpm e NREM de 37 - 61 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados da registra polissonográfica, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 12,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Descrição do Exame Polissonográfico

1/5

Nome: KIMIYOSHI KUROSAWA			
Sexo: M		Idade: 69 anos	
IMC: 32,0	Data do Exame: 27/02/2024	Peso: 85 Kg	Altura: 1,63 m
		Exame: 13242_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:38:17 horas e encerrado às 06:00:55 horas, com latência para o sono de 0 minutos e latência para o sono REM de 46 minutos. O tempo total de sono foi de 206,5 minutos, com eficiência do sono de 64,4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	4,0%	Até 5%
Estágio 2	56,4%	45 - 55%
Estágio 3	10,5%	> 15%
Sono REM	29,1%	20 - 25%
Eficiência do sono	64,4%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 158,5 minutos ocorreram 58 despertares (índice de 12,1/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 44 bpm, a maior de 56 bpm e a menor de 41 bpm. Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.

Ocorreram 309 eventos respiratórios, sendo 0 central e 309 obstrutivos. Sendo 193 apnéias, 116 hipopnéias e 0 RERAS. O Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 64,7/hora, sendo 40,4 apnéia/hora e 24,3 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 21,0 e a duração máxima de 56,9.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 62,5/hora, sendo 38,8 apnéia/hora e 23,7 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 95%, sendo a saturação média de 92%, a maior de 98% e a mínima de 74%, permanecendo 68,9 minutos (13,2%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,3 minutos (0,1%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 322 dessaturações. Índice de dessaturações: 67,4/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 65,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 69,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Bruno de Andrade Soares
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 104075